

Plaie

Face à une urgence ou une détresse vitale, ou en cas d'aggravation

- appliquer la conduite à tenir adaptée et réaliser en priorité les gestes d'urgence qui s'imposent ;

En présence d'une plaie grave

- ne jamais retirer le corps étranger **pénétrant** (couteau, morceau de verre, etc.)¹ ;
- installer la victime en position d'attente, confortablement² et sans délai :
 - assise³ en laissant la plaie à l'air libre en présence d'une plaie au thorax ;
 - allongée⁴, jambes fléchies⁵ en présence d'une plaie de l'abdomen ;
 - allongée, yeux fermés⁶ en demandant de ne pas bouger la tête en présence d'une plaie à l'œil ;
 - allongée⁷ dans tous les autres cas.
- **à l'exception des plaies du thorax**, protéger la plaie par un pansement ou un champ stérile humidifié⁸ ;
- protéger la victime contre le froid, la chaleur ou les intempéries ;
- poursuivre le bilan et surveiller attentivement son état du fait d'un risque d'aggravation brutale.

En présence d'une plaie simple

- se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique ;
- se protéger par le port de gants ;
- nettoyer la plaie :
 - avec de l'eau courante (propre) ou en bouteille, à défaut avec du sérum physiologique ;
 - utiliser du savon si la plaie est souillée ;
 - s'aider si besoin d'une compresse pour enlever les souillures.
- sécher la zone autour de la plaie et la protéger par un pansement ;
- conseiller à la victime de consulter un médecin si :
 - elle n'est pas à jour de sa vaccination antitétanique ;
 - la plaie devient chaude, rouge, si elle suinte, si elle gonfle ou si elle continue de faire mal dans les vingt-quatre heures.

En présence d'une plaie par injection de liquide sous pression

- recueillir la nature du produit injecté et la valeur de la pression d'injection, si possible ;
- demander un avis médical en transmettant le bilan.

¹ Cela risque d'aggraver la plaie.

² Par exemple sur un brancard, un lit, une chaise, un canapé ou à défaut sur le sol.

³ La position assise facilite la respiration lorsque l'on est en présence d'une plaie au thorax.

⁴ La position allongée permet de prévenir les détresses et d'éviter les complications.

⁵ La flexion des jambes d'une victime préalablement allongée permet, par le relâchement des muscles de l'abdomen, de diminuer la douleur.

⁶ La fermeture des yeux et l'immobilité de la tête permettent de limiter les risques d'aggravation de la lésion de l'œil.

⁷ La position allongée permet de prévenir les détresses et d'éviter les complications.

⁸ Eau stérile ou sérum physiologique.

En présence d'un traumatisme dentaire¹

- se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique ;
- se protéger par le port de gants ;
- aider la personne à arrêter le saignement dans la bouche :
 - demander à la victime de se rincer la bouche avec de l'eau, si possible froide ;
 - appliquer une compresse humide sur la zone qui saigne dans la bouche² ;
 - demander à la victime de mordre la compresse humide.
- conditionner la dent tombée :
 - la récupérer en la saisissant par la couronne et pas par la racine ;
 - la rincer³ si elle est souillée pendant 10 secondes maximum ;
 - l'envelopper dans un film étirable alimentaire ;
 - à défaut, la conserver dans un petit récipient contenant⁴ du lait de vache ou de la salive de la victime
- faire transporter la dent conditionnée avec la victime ;
- indiquer à la victime de consulter immédiatement un chirurgien-dentiste.

¹ Délogement d'une dent suite à un choc.

² Ne pas le faire si la victime risque d'avaler la compresse (par exemple, un petit enfant, une personne agitée ou qui présente des troubles de la conscience).

³ Avec du sérum physiologique ou sous l'eau courante.

⁴ Il ne faut pas la conserver dans de l'eau du robinet ni dans du sérum physiologique.